

Médecine palliative

Répétitoires

Prof. G.D. Borasio, Dr. M. Beauverd MER
Dr. C. Mazzocato PD MER

Vignette 1

1. Un patient de 75 ans, présentant un cancer de la prostate métastatique au niveau osseux, vous consulte en raison de douleurs osseuses de la région inguinale gauche.

Ses douleurs sont permanentes, à 6/10 sur l'EVA, le réveillant la nuit. Traitement actuel : ibuprofène (Brufen®) 600 mg aux 8h.

Quel traitement antalgique proposez-vous?

- A. Avis d'un radio-oncologue
- B. Paracétamol (4g/j) associé à l'AINS
- C. Hydromorphone à effet immédiat aux 4h
- D. Morphine à effet immédiat aux 4h
- E. Morphine retard (MST®) en réserve

Réponse

1. Un patient de 75 ans, présentant un cancer de la prostate métastatique au niveau osseux, vous consulte en raison de douleurs osseuses de la région inguinale gauche.

Ses douleurs sont permanentes, à 6/10 sur l'EVA, le réveillant la nuit. Traitement actuel : ibuprofène (Brufen®) 600 mg aux 8h.

Quel traitement antalgique proposez-vous?

- A. Avis d'un radio-oncologue
- B. Paracétamol (4g/j) associé à l'AINS
- C. Hydromorphone à effet immédiat aux 4h
- D. Morphine à effet immédiat aux 4h**
- E. Morphine retard (MST®) en réserve

Vignette 2

3. Une patiente de 42 ans connue pour un carcinome mammaire métastatique (poumons, rachis et foie) est hospitalisée à sa demande dans une unité de soins palliatifs. Elle se plaint d'une dyspnée rapidement progressive dont l'intensité s'élève à 8/10 et d'une toux d'apparition nouvelle. Elle est très angoissée. Elle est fébrile à 38.5, l'auscultation pulmonaire est sans particularité. Elle ne se plaint pas de douleurs. Traitement à l'entrée : Dexaméthasone 8mg 1x/j, Paracétamol 1g 4x/j, Tramadol retard 100mg 2x/j

Quelle attitude est la plus appropriée ?

- A. ↑Dexaméthasone à 16mg/j par voie sous-cutanée et oxygénothérapie à 6 l/min.
- B. Antibiothérapie par Ceftriaxone 2g/j iv et oxygénothérapie à 6l/min.
- C. Passage une forme à action rapide de Tramadol po, ↑Dexaméthasone à 16mg /j et prescription de Lorazépam 1mg 4x/j (Temesta®)
- D. Morphine à action rapide par voie sous-cutanée (4 mg aux 4h) et mise à disposition d'un ventilateur.
- E. Perfusion continue de Midazolam (Dormicum®) à 1mg/h iv à titrer rapidement.

Réponse

3. Une patiente de 42 ans connue pour un carcinome mammaire métastatique (poumons, rachis et foie) est hospitalisée à sa demande dans une unité de soins palliatifs. Elle se plaint d'une dyspnée rapidement progressive dont l'intensité s'élève à 8/10 et d'une toux d'apparition nouvelle. Elle est très angoissée. Elle est fébrile à 38.5, l'auscultation pulmonaire est sans particularité. Elle ne se plaint pas de douleurs. Traitement à l'entrée : Dexaméthasone 8mg 1x/j, Paracétamol 1g 4x/j, Tramadol retard 100mg 2x/j

Quelle attitude est la plus appropriée ?

- A. ↑Dexaméthasone à 16mg/j par voie sous-cutanée et oxygénothérapie à 6 l/min.
- B. Antibiothérapie par Ceftriaxone 2g/j iv et oxygénothérapie à 6l/min.
- C. Passage une forme à action rapide de Tramadol po, ↑Dexaméthasone à 16mg /j et prescription de Lorazépam 1mg 4x/j (Temesta®)
- D. Morphine à action rapide par voie sous-cutanée (4 mg aux 4h) et mise à disposition d'un ventilateur.**
- E. Perfusion continue de Midazolam (Dormicum®) à 1mg/h iv à titrer rapidement.

Vignette 3

4. Madame Blanc, 75 ans, souffre d'un cancer du pancréas. Elle est actuellement à domicile. Elle reçoit de la morphine à visée antalgique et un antidépresseur pour un état dépressif sévère. Son mari vous appelle car elle se comporte « bizarrement » depuis deux jours. Lors de votre visite, elle est agitée avec hallucinations visuelles, désorientée, très anxieuse. Elle ne s'alimente ni ne s'hydrate plus.

Quel est le diagnostic le plus plausible ?

- A. Une aggravation de son état dépressif
- B. Un delirium
- C. Une démence paranéoplasique
- D. Une décompensation psychotique liée à la morphine
- E. Des manifestations de son entrée dans la phase agonale

Vignette 3

4. Madame Blanc, 75 ans, souffre d'un cancer du pancréas. Elle est actuellement à domicile. Elle reçoit de la morphine à visée antalgique et un antidépresseur pour un état dépressif sévère. Son mari vous appelle car elle se comporte « bizarrement » depuis deux jours. Lors de votre visite, elle est agitée avec hallucinations visuelles, désorientée, très anxieuse. Elle ne s'alimente ni ne s'hydrate plus.

Quel est le diagnostic le plus plausible ?

- A. Une aggravation de son état dépressif
- B. Un delirium**
- C. Une démence paranéoplasique
- D. Une décompensation psychotique liée à la morphine
- E. Des manifestations de son entrée dans la phase agonale

Vignette 4

5. Vous avez diagnostiqué un delirium. En attendant le résultat des examens de laboratoire, quel traitement médicamenteux prescrivez-vous en première intention?
- A. De l'halopéridol (Haldol®)
 - B. De l'halopéridol (Haldol®) + rotation opioïde
 - C. Un neuroleptique sédatif, tel que la lévomépromazine (Nozinan ®)
 - D. Une benzodiazépine, telle que le lorazepam (Temesta ®)
 - E. Aucun, mais stop morphine/antidépresseur

Réponse

5. Vous avez diagnostiqué un delirium. En attendant le résultat des examens de laboratoire, quel traitement médicamenteux prescrivez-vous en première intention?
- A. De l'halopéridol (Haldol®)
 - B. De l'halopéridol (Haldol®) + rotation opioïde**
 - C. Un neuroleptique sédatif, tel que la lévomépromazine (Nozinan ®)
 - D. Une benzodiazépine, telle que le lorazepam (Temesta ®)
 - E. Aucun, mais stop morphine/antidépresseur

Vignette 5

6. Madame F., 87 ans, est admise aux urgences suite à un AVC massif dans l'hémisphère gauche. Elle est hémiparétique et aphasique. Son potentiel de réadaptation est très bas selon les neurologues, mais elle pourrait peut-être survivre à l'AVC avec des soins intensifs.
- La fille de la patiente plaide pour des « soins de confort ». Le fils exige de façon agressive que « tout soit fait » pour maintenir en vie sa mère le plus longtemps possible. Quelle est votre tâche primaire ?
- A. Suivre la décision de la fille et appeler les soins palliatifs.
 - B. Suivre la décision du fils, car il faut faire tout le possible pour sauver la vie de la patiente
 - C. Organiser au plus vite un réseau avec les neurologues et les proches pour vérifier la volonté présumée de la patiente
 - D. Demander une consultation d'urgence à l'unité d'éthique
 - E. Vérifier s'ils existent des directives anticipées

Réponse

6. Madame F., 87 ans, est admise aux urgences suite à un AVC massif dans l'hémisphère gauche. Elle est hémiplégique et aphasique. Son potentiel de réadaptation est très bas selon les neurologues, mais elle pourrait peut-être survivre à l'AVC avec des soins intensifs.
- La fille de la patiente plaide pour des « soins de confort ». Le fils exige de façon agressive que « tout soit fait » pour maintenir en vie sa mère le plus longtemps possible. Quelle est votre tâche primaire ?
- A. Suivre la décision de la fille et appeler les soins palliatifs.
 - B. Suivre la décision du fils, car il faut faire tout le possible pour sauver la vie de la patiente
 - C. Organiser au plus vite un réseau avec les neurologues et les proches pour vérifier la volonté présumée de la patiente
 - D. Demander une consultation d'urgence à l'unité d'éthique
 - E. Vérifier s'ils existent des directives anticipées**